



SURAT KETERANGAN KERJA
NOMOR : 351.12/I-SKT/DIR/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Resti Lestantini, M. Kes
Jabatan : Direktur RS Prima Husada Malang
Alamat : Banjararum Selatan No. 3B Mondoroko, Singosari – Malang

Dengan ini menerangkan bahwa tersebut di bawah ini :

Nama : Pipin Purwa Ningrum, S. Farm., Apt
Jabatan : Apoteker
Alamat : Dsn Tanggul, RT/RW 005/002 Kel. Tulungagung, Kec. Besuki – Kab. Tulungagung

Nama tersebut diatas adalah benar merupakan Staf Apoteker yang bekerja di Rumah Sakit Prima Husada Malang sejak 25 November 2020 sampai dengan sekarang dan yang bersangkutan selama ini telah bekerja dengan baik. Surat keterangan ini diberikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Kredit Mitraguna di PT Bank Syariah Indonesia (Persero) tbk.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2026

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

EVALUASI KINERJA STAF INSTALASI FARMASI - APOTEKER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Nama Lengkap : apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : S1 - Apoteker
 Kompetensi Khusus : Apoteker
 Unit Kerja : Farmasi Rawat Inap
 Periode Penilaian : Semester I (Januari - Juni 2026)

No	Kompetensi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
I. Perilaku Kerja							
1	Komunikasi						
	a. Menunjukkan komunikasi yang baik dengan kontak mata, bahasa tubuh dan nada suara yang menunjukkan perhatian kepada pasien dan keluarga		3	3	3	3	3
	b. Komunikasi dengan teman sejawat		3	3	3	3	3
	c. Komunikasi dengan atasan		3	3	3	3	3
2	Mampu berkoordinasi dengan penanggung jawab shift dan staf lainnya termasuk teman sejawat lain ditunjukkan dengan tidak ada konflik secara internal		3	3	3	3	3
3	Tanggap dan cepat merespon permasalahan dan kebutuhan di unitnya		3	3	3	3	3
4	Mampu berbagi pengalaman dalam bentuk pendidikan atau pengetahuan kepada anggota tim yang lainnya		3	3	3	3	3
5	Disiplin						
	a. Datang tepat waktu melakukan tugas shift sesuai jadwal dinas yang telah ditentukan dan apabila ada tukar dinas sesuai dengan aturan yang berlaku		3	4	3	4	4
	b. Tidak meninggalkan tempat kerja selama berada di jam kerja dan apabila meninggalkan tempat kerja dengan seijin dari atasan		4	4	4	4	4

	c. Mematuhi semua peraturan di rumah sakit termasuk dalam hal penggunaan seragam dan atribut secara benar		4	4	4	4	4
6	Mampu menentukan alternatif penyelesaian masalah terkait tugas dan tanggung jawabnya		3	3	3	3	3
NILAI			32	33	32	33	33
RATA- RATA			3.2	3.3	3.2	3.3	3.3
II. Pengembangan Profesional							
1	Pelayanan pasien						
	a. Memberikan pelayanan dengan tepat dan efektif		3	3	3	3	3
	b. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga		3	3	3	3	3
	c. Memahami dan menghargai privasi pasien		3	3	3	3	3
2	Profesionalisme kerja berdasarkan prinsip etik dan mutu						
	a. Komitmen untuk secara terus menerus mengembangkan profesionalitas kerja		3	3	3	3	3
	b. Komitmen secara terus menerus menjunjung tinggi etika profesi		3	3	3	3	3
	c. Peka terhadap keragaman sikap tanggung jawab terhadap pasien, profesi dan masyarakat		4	4	4	4	4
	d. Menerapkan 6S (senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar)		4	4	4	4	4
	e. Pengembangan profesionalisme sesuai RKK		4	4	4	4	4
3	Praktik berbasis sistem						
	a. Pemahaman terhadap perundang-undangan tentang keprofesian dan Pelayanan Kesehatan		4	4	4	4	4
	b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pelayanan di RS		4	4	4	4	4
	c. SIP dan STR aktif		4	4	4	4	4
NILAI			39	39	39	39	39
RATA- RATA			3.545454545	3.545454545	3.545454545	3.545454545	3.545454545
III. Kinerja Klinis			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
A. Kewenangan Klinis							
1	Profesionalisme						
	a. Menerapkan Kode Etik dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dalam praktik sesuai etika, hukum, dan nilai profesional.		4	4	4	4	4
	b. Menerapkan pertimbangan profesional dalam melakukan praktik kefarmasian dengan mengindahkan kode etik dan disiplin.		4	4	4	4	4
	c. Menerapkan ketentuan perundang – undangan di bidang kefarmasian secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum dan penerapannya dalam praktik.		4	4	4	4	4

	d. Menerapkan pelayanan sesuai standar pelayanan kefarmasian dan standar prosedur operasional.		4	4	4	4	4
	e. Menerapkan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien.		4	4	4	4	4
	f. Menerapkan kolaborasi interprofesi.		3	3	3	3	3
2	Mawas Diri dan Pengembangan Diri						
	a. Meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan.		3	3	3	3	3
	b. Mengembangkan inovasi pelayanan kefarmasian.		3	3	3	3	3
3	Komunikasi Efektif						
	a. Melakukan komunikasi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan.		4	4	4	4	4
	b. Memberikan konseling kepada pasien sesuai prosedur yang ditetapkan.		3	3	3	3	3
	c. Memberikan edukasi terkait penggunaan obat sebagai bagian dari promosi kesehatan rumah sakit.		4	4	4	4	4
4	Landasan Ilmiah Ilmu Farmasi, Biomedik, Humaniora dan Kesehatan Masyarakat						
	a. Menggunakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan kefarmasian berbasis bukti (evidence-based medicines) dan memastikan keamanan penggunaan obat (medication safety).		4	4	4	4	4
	b. Melakukan pengkajian administratif, farmasetik dan klinis.		3	3	3	3	3
	c. Melakukan pemantauan terapi obat pada kriteria pasien yang telah ditentukan.		4	4	4	4	4
	d. Memberikan rekomendasi waktu pemberian obat dengan mempertimbangkan interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan.		4	4	4	4	4
	e. Melakukan monitoring terkait efek samping obat.		3	3	3	3	3
	f. Memberikan rekomendasi terkait pengobatan jika terjadi alergi dan ROTD/ESO.		2	2	2	2	2
	g. Memberikan edukasi berbasis sosial budaya.		4	4	4	4	4
	h. Melakukan evaluasi penggunaan obat dan manajemen stok		3	3	3	3	3
	i. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik sebagai bagian dari program pengendalian resistensi antibiotik.		2	2	2	2	2
	j. Melakukan pengkajian kesesuaian resep berdasarkan formularium rumah sakit dan formularium nasional.		3	3	3	3	3
	k. Melakukan identifikasi pengelolaan limbah sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).		3	3	3	3	3
	l. Menerapkan prinsip keselamatan kerja untuk mengelola masalah yang berkaitan dengan kefarmasian.		3	3	3	3	3

	Keterampilan Apoteker						
	Penyimpanan						
	a. Melakukan monitoring suhu, kelembaban dan mutu produk dalam penyimpanan, mengidentifikasi adanya sediaan yang rusak, kedaluwarsa, dan menetapkan tindak lanjut penanganan sediaan yang rusak atau kedaluwarsa.		3	3	3	3	3
	b. Melakukan supervisi penyimpanan berdasarkan stabilitas suhu yang diperlukan, penataan sesuai alfabetis, pengelompokan bentuk sediaan dan rute pemberian obat, kesesuaian penataan dengan prinsip First Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO).		3	3	3	3	3
	c. Melakukan supervisi terkait penyimpanan dan penempelan label/ stiker penandaan obat Look Alike Sound Alike (LASA) dan High Alert.		3	3	3	3	3
	d. Melakukan supervisi terkait penyimpanan dan penempelan label/ stiker penandaan sediaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan gas medis.		3	3	3	3	3
	e. Melakukan supervisi terkait penyimpanan sediaan obat narkotika dan psikotropika, obat-obat tertentu (OOT) dan prekursor.		3	3	3	3	3
	f. Melakukan supervisi penyimpanan floor stock yang tersedia di unit RS.		3	3	3	3	3
	g. Melakukan supervisi terkait box emergency (BE) yang tersedia di unit RS.		4	4	4	4	4
	h. Melakukan dokumentasi kegiatan penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.		4	4	4	4	4
	Pengelolaan						
	a. Melakukan pengelolaan sediaan obat narkotika dan psikotropika, obat-obat tertentu (OOT) dan prekursor.		4	4	4	4	4
	b. Melakukan pengelolaan sediaan obat Cold Chain Product (CCP), High Alert, obat program pemerintah, gas medis dan sediaan bahan berbahaya dan beracun (B3).		4	4	4	4	4
	Distribusi						
	a. Melakukan supervisi terkait penyiapan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan yang akan didistribusikan.		3	3	3	3	3
	b. Melakukan pengemasan dan pelabelan sediaan repacking.		3	3	3	3	3
	c. Melakukan pendistribusian sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan secara Unit Dose Dispensing (UDD), floor stock, dan individual prescribing.		3	3	3	3	3
	d. Melakukan pencatatan kartu stok pemasukan dan pengeluaran.		3	3	3	3	3
	e. Melakukan prosedur, melaksanakan dan evaluasi prosedur penyimpanan dan pendistribusian Cold Chain Product (CCP).		3	3	3	3	3

f. Melakukan supervisi dan laporan evaluasi terkait kegiatan distribusi di RS.		3	3	3	3	3
g. Melakukan dokumentasi kegiatan distribusi sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan.		3	3	3	3	3
Penarikan dan Pemusnahan						
a. Melakukan penarikan (Recall) dan retur sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) substandar.		3	3	3	3	3
b. Merancang prosedur pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan dimusnahkan.		3	3	3	3	3
c. Melakukan karantina sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terpisah yang akan dimusnahkan.		3	3	3	3	3
d. Melakukan kegiatan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai prosedur yang telah ditetapkan.		3	3	3	3	3
e. Melakukan dokumentasi kegiatan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).		3	3	3	3	3
Pelayanan Kefarmasian						
a. Melakukan pengkajian resep dari dokter untuk memastikan legalitas (administrasi), kesesuaian farmasetik, serta pengelolaan masalah klinis potensial maupun aktual.		3	3	3	3	3
b. Menetapkan metode penggalan data untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan sediaan farmasi.		4	4	4	4	4
c. Menerima permintaan informasi yang berkaitan dengan sediaan farmasi.		3	3	3	3	3
d. Menetapkan sumber data dan teknik penelusuran informasi untuk memperoleh informasi yang sah.		3	3	3	3	3
e. Melakukan penelusuran informasi, menganalisis secara kritis, dan mengorganisasikan informasi.		3	3	3	3	3
f. Menetapkan media penyampaian informasi, mengkomunikasikan dan mendiseminasikan informasi tentang sediaan farmasi kepada pasien, keluarga pasien dan atau tenaga kesehatan lain.		4	4	4	4	4
g. Melakukan dokumentasi kegiatan pelayanan informasi obat		4	4	4	4	4
Compounding dan Dispensing Sediaan Steril dan Non Steril						
a. Melakukan penyiapan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai peresepan.		4	4	4	4	4

b. Melakukan perhitungan kebutuhan sediaan steril dan non steril untuk peracikan dan rekonstitusi.	4	4	4	4	4
c. Melakukan penyiapan dan rekonstitusi sediaan steril menggunakan teknik aseptis.	4	4	4	4	4
d. Melakukan penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan non steril.	4	4	4	4	4
e. Melakukan perhitungan dan pengenceran sediaan elektrolit konsentrat.	4	4	4	4	4
f. Melakukan monitoring dan supervisi terkait penyiapan, pengemasan, dan pelabelan/ pemberian etiket sediaan farmasi yang akan di distribusikan kepada pasien dan atau tenaga medis lain sesuai peresepan.	4	4	4	4	4
g. Melakukan penyiapan obat narkotika/ psikotropika.	4	4	4	4	4
h. Melakukan monitoring terkait kebersihan, kerapian, dan kesesuaian tempat kerja untuk penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan steril dan non steril.	4	4	4	4	4
Penyediaan Informasi Obat					
a. Memberikan konseling kepada pasien sesuai prosedur yang ditetapkan.	4	4	4	4	4
b. Memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien, keluarga pasien dan atau tenaga medis lain menggunakan komunikasi yang efektif.	4	4	4	4	4
c. Melakukan dokumentasi kegiatan konseling dan pemberian informasi obat.	4	4	4	4	4
Rekonsiliasi Obat					
a. Melakukan penelusuran informasi riwayat pengobatan pasien.	4	4	4	4	4
b. Melakukan penelusuran data riwayat penggunaan obat dari rekam medis.	4	4	4	4	4
c. Melakukan rekonsiliasi awal medis, transfer dan discharge.	4	4	4	4	4
d. Melakukan dokumentasi kegiatan rekonsiliasi obat.	4	4	4	4	4
Visite					
a. Melakukan wawancara untuk menggali data/ informasi dari penerima pelayanan kefarmasian atau keluarganya dengan memperhatikan aspek budaya, bahasa, demografi, dan kondisi fisik pihak yang diwawancara saat visite pasien di rawat inap.	4	4	4	4	4
b. Melakukan dokumentasi hasil visite pasien di lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dan formulir edukasi.	4	4	4	4	4
d. Memberikan rekomendasi terkait pengobatan jika terjadi alergi dan ROTD/ ESO.	2	2	2	2	2
Farmakovigilans					

	a. Mendeteksi, menilai dan menindak lanjut adanya kejadian efek samping atau masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi.	2	2	2	2	2
	b. Melakukan dokumentasi monitoring efek samping obat menggunakan formulir MESO kuning dan atau melalui website https://e-meso.pom.go.id/	2	2	2	2	2
	c. Melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi berulangnya kejadian efek samping atau masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi.	2	2	2	2	2
	Catatan Penggunaan Obat Pasien					
	a. Melakukan monitoring pengobatan pasien dari rumah.	4	4	4	4	4
	b. Melakukan monitoring pengobatan pasien secara mandiri.	4	4	4	4	4
	c. Melakukan monitoring pengobatan pasien selama rawat inap.	4	4	4	4	4
	Pengamanan Sediaan Farmasi					
	a. Melakukan kegiatan penulisan kartu stok pemasukan dan pengeluaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.	1	1	1	1	1
	b. Melakukan monitoring expired date (ED)/ kedaluwarsa dan perhitungan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara bertahap (random stok).	3	3	3	3	3
	c. Melakukan evaluasi dengan kartu stok, monitoring expired date (ED)/ kedaluwarsa dan perhitungan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara keseluruhan (stok opname).	3	3	3	3	3
	Pelaporan dan Pencatatan					
	a. Melakukan evaluasi dengan kartu stok, monitoring expired date (ED)/ kedaluwarsa dan perhitungan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara keseluruhan (stok opname)	3	3	3	3	3
	b. Pelaporan pelayanan kefarmasian pada website KEMENKES (SIPNAP, SIMONA, SIHA, SITB, E-MONEV, SMILE).	3	3	3	3	3
	Pengelolaan Praktik Kefarmasian					
	a. Menjamin kepuasan pelayanan Praktik Kefarmasian di Rumah Sakit.	4	4	4	4	4
	b. Memiliki kemampuan manajemen konflik.	4	4	4	4	4
	c. Mengoordinasikan kerjasama tim (team work).	4	4	4	4	4
	d. Menerapkan prinsip K3 di fasilitas kefarmasian.	4	4	4	4	4
	B. Etik dan Disiplin					
6	Pelanggaran Etik	4	4	4	4	4
	Pelanggaran Disiplin	4	4	4	4	4
	Komplain pasien	4	4	4	4	4
	Kejadian IKP	1	4	4	4	4

C. Mutu							
7	Kepatuhan identifikasi pasien		4	4	4	4	4
	Kepatuhan kebersihan tangan		4	4	4	4	4
	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri		4	4	4	4	4
	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional		4	4	4	4	4
	Kepatuhan Verifikasi Indentitas Pasien Sebelum Pemberian Obat Pasien Rawat Jalan		4	4	4	4	4
	Waktu Tunggu Obat Racikan < 60 menit		4	4	4	4	4
	Kepatuhan Penempelan Label Obat LASA dan Obat-Obatan High Alert di Rawat Inap		4	4	4	4	4
	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat		4	4	4	4	4
	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat		4	4	4	4	4
	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat		4	4	4	4	4
	Kejadian Kesalahan Input E-Resep		4	4	4	4	4
	Angka Keterlambatan Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit		4	4	4	4	4
	Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap		4	4	4	4	4
NILAI		0	354	357	357	357	357
RATA- RATA		0	3.470588235	3.5	3.5	3.5	3.5

PENILAIAN AKHIR (PENJUMLAHAN RATA- RATA)

No	Kompetensi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Nilai Perilaku Kerja		3.2	3.3	3.2	3.3	3.3
2	Nilai Pengembangan Profesi		3.545454545	3.545454545	3.545454545	3.545454545	3.545454545
3	Nilai Kinerja Klinis		3.470588235	3.5	3.5	3.5	3.5
JUMLAH RATA- RATA (A)			10.21604278	10.34545455	10.24545455	10.34545455	10.34545455
HASIL SKOR AKHIR (Sesuai Rumus Penjumlahan)			85.13368984	86.21212121	85.37878788	86.21212121	86.21212121
Kesimpulan Staf (tuliskan dengan kode : SB / B / C/ K/ SK)			SB	SB	SB	SB	SB

Parameter Nilai	
Sangat baik	4
Baik	3

Kurang	2
Sangat Kurang	1
Parameter Prosentase	
Sangat Baik	81% - 100%
Baik	61% - 80%
Cukup	41% - 60%
Kurang	21% - 40%
Sangat Kurang	1% - 20%
Rekap Penilaian	
JAN	-
FEB	Petugas depo farmasi menemukan Olanzapin tab 10 mg di rak obat generik sisa 150 tablet. Farmasi melakukan telusur obat dan menghubungi pasien mulai penjualan tanggal 27/12/2025 sampai 31 januari 2026 (sesuai daftar terlampir). Beberapa pasien yang dihubungi obatnya sudah benar. Ada 4 pasien yang nomornya tidak terdeteksi kemudian farmasi order primantara untuk ke rumah pasien mengecek langsung. Ditemukan pasien an Devi masih ada Olanzapin tab 10 mg sebanyak 42 tablet dan sudah diminum 18 tab dimana resep dan etiket obat Olanzapin tab 5 mg. Primantara menarik obat yang salah dan menggantikan dengan obat yang benar sesuai resep. Petugas yang melakukan kesalahan : semua petugas farmas karena tidak ada yang double check.
MAR	-
APR	-
MEI	-
JUN	-

[illegible]